

10. 모범사례

○ 입원환자분류체계(KDRG) 관리를 통한 전문진료질병군 상향을 위한 노력

심사과는 상급종합병원지정평가 및 의료질평가의 지표 중 하나인 입원 전문진료질병군 비율을 상향하고자 지속적으로 노력하였음. 그 결과로 원내 KDRG 프로그램을 구축하였고, KDRG 자동번호생성, KDRG통계, KDRG 질병군별 분류통계 등의 화면을 구현하여 심사과 및 관련부서에서 전문진료질병군 현황을 확인할 수 있고, 정확한 상병 산정기준 등 질병군에 대한 다양한 정보를 제공하고 있음.

현재 구성된 프로그램 중 KDRG 자동번호생성 배치기능을 통하여 일정 시간마다 자료가 업데이트되고 있음. 청구 연월별로 전체 대상자를 확인할 수 있고 기간조회 조건을 달리하여 기간별 대상자 환자 개인별 조회기능을 활용할 수 있으며 엑셀저장 기능으로 대상자별 상병 및 처치에 대한 전체 자료를 확인할 수 있음.

KDRG통계프로그램은 진료과별, 의사별 전문진료질병군 현황과 해당 DRG명의 환자수를 파악할 수 있음. 조회조건을 두어 기간별 조회가 가능하며 상급종합병원지정평가와 의료질평가의 달라지는 기준에 따라 낮병동 제외/포함, 응급실퇴원 제외/포함 등 조건별로 자료 구현이 가능함.

질병군별 진료과 분류 기능은 청구월별 기간을 선택하여 월별, 분기별, 누적 등 조건에 따라 질병군의 비율 및 전체 비율을 확인할 수 있고 상급종합병원지정평가와 의료질평가의 달라지는 기준에 따라 낮병동 포함 여부, 응급실퇴원 포함 여부의 조건을 달리하여 확인이 가능하며, 엑셀저장 기능을 활용하여 진료과별/진료과내 의사별로 세분화된 데이터를 추출이 가능하며, 전부서 홍보 및 분기별 질병군 현황 보고에 활용하고 있음.

위와 같이 심사과는 수년간의 점검과 수정보완을 거쳐 구축된 프로그램을 통해 전문진료질병군 비율 및 외래경증환자 비율을 효율적으로 관리함으로써 전문진료질병군 비율이 2021년 41%, 2022년 43%, 2023년 43.6%로 계속 증가하고 있

으며, 외래경증환자 비율이 2021년 2.95%, 2022년 1.88%, 2023년 1.51%로 감소하는데 기여하였음.